

Abdominal Migren

Rome IV temelli pozitif tanı, migren spektrumundaki yerinin tanınması, tetikleyici kaçınma ve dozlu profilaksi (siproheptadin, pizotifen, propranolol) ile izlem çerçevesi. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Rome IV

Migren spektrumu

Tetikleyici kaçınma

Profilaksi

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Abdominal migren (AM), Rome IV'te tekrarlayan karın ağrısı bozuklukları arasında yer alan; paroksizmal, stereotipik, şiddetli ve engelleyici periumbilikal/orta hat/diffüz karın ağrısı atakları ile giden bir bozulmuş beyin-bağırsak etkileşimidir. Ataklar en az 1 saat sürer, haftalar-aylarca süren tam sağlıklı dönemlerle ayrılır ve anoreksi, bulantı, kusma, baş ağrısı, fotofobi veya solukluktan en az ikisi eşlik eder. Tanı için ölçütler ≥ 2 kez ve son 6 ayda karşılanmalıdır. Pik yaş 4-10 (ortalama ~ 7); erişkin migren için güçlü bir öncüdür ve olguların önemli kısmında ailede migren öyküsü vardır.

Paroksizmal + stereotipik ataklar

Ataklar arası tam iyilik

ICHD-3: migrenle ilişkili epizodik sendrom

Ailede migren öyküsü sık

Öyküde sorgula

- Atak paterni: başlangıç-süre (≥ 1 saat), lokalizasyon (orta hat/periumbilikal), şiddet ve engelleyicilik (okulu/aktiviteyi kesme)
- Stereotipi: her atağın birbirinin aynı olması; ataklar arası tam asemptomatik dönem
- Eşlik eden bulgular: anoreksi, bulantı, kusma, baş ağrısı, fotofobi, solukluk (≥ 2 gerekli)
- Tetikleyiciler: stres/heyecan, açlık-öğün atlama, uyku bozukluğu, seyahat/hareket, çikolata-peynir-narenciye, kafein, MSG/nitrit, parlak-titreşen ışık
- Aile öyküsü: migren, taşıt tutması; kişisel öykü: infantil kolik, siklik kusma sendromu, benign paroksizmal vertigo
- Alarm taraması: kilo kaybı, gece uyandıran/lokalize ağrı, safralı kusma, kanama, büyüme duraklaması

Muayenede değerlendir

- Atak dışı muayene tipik olarak tamamen normaldir (bu, tanıyı destekleyen bir bulgudur)
- Büyüme: boy-kilo persentilleri ve boy hızı; duraklama alarm bulgusudur
- Karın: organomegali, kitle, lokalize/rebound hassasiyet, distansiyon organik hastalık lehinedir
- Atak sırasında görülürse: solukluk, halsizlik, bazen düşük ateşsiz otonom bulgular; cerrahi karın dışlanmalı
- Perianal/rektal: fissür, fistül, gizli kan (IBD ipuçları); ekstraintestinal: artrit, aftöz lezyon
- Nörolojik: baş ağrısı baskınsa fokal defisit/papilödem taraması

Alarm bulgusu yoksa ve ataklar arası çocuk tamamen iyiye AM, dışlama tanısı değil **pozitif klinik tanı** olarak konur; kapsamlı invaziv tetkik rutin olarak gerekmez.

02 Etiyoloji ve mekanizma

AM, migrenle paylaşılan nörobiyoloji zemininde gelişen bir beyin-bağırsak eksen bozukluğudur. Baskın mekanizmayı öngörmek profilaktik ajan seçimini (serotonerjik antagonist mi, beta-bloker mi) ve tetikleyici danışmanlığını yönlendirir.

Migren biyolojisi ile örtüşme

- AM, migren spektrumunun bir parçası (ICHD-3 epizodik sendrom)
- Çocuklukta AM, erişkin migren için güçlü öngördürücü
- Aynı profilaktiklere yanıt (antiserotonerjik, beta-bloker)

Serotonerjik (5-HT) disregülasyon

- 5-HT aracılı visseral hipersensitivite ve motilite değişimi
- Bulantı-kusma ve ağrı algısında rol
- Hedef: pizotifen, siproheptadin (5-HT₂ antagonisti)

Otonom / vazomotor disregülasyon

- Solukluk, anoreksi, halsizlik gibi otonom eşlikçiler
- HPA eksen ve sempatovagal dengesizlik
- Hedef: beta-adrenerjik modülasyon (propranolol)

Genetik yatkınlık

- Ailede migren öyküsü olguların çoğunda mevcut
- Poligenik yatkınlık; taşıt tutması birlikteliği
- Aile öyküsü tanıyı destekler, tetkik ihtiyacını azaltır

Tetikleyiciler ve çevresel etmenler

- Stres/heyecan, açlık-öğün atlama, uyku düzensizliği
- Amin içeren gıdalar, kafein, MSG/nitrit, parlak ışık, seyahat
- Hedef: sistematik tetikleyici günlüğü ve kaçınma

Nöroinflamasyon / bağırsak duyarlılığı

- Trigemiovasküler yolak ve santral duyarlılaşma
- Visseral afferentlerde eşik düşüklüğü
- Hedef: nöromodülatör (amitriptilin) seçili olguda

03 Karar akışı

İlk çatal alarm bulgusudur; ikinci çatal Rome IV ölçütlerinin (stereotipik atak, ≥ 2 otonom eşlikçi, ataklar arası tam iyilik) karşılanmasıdır.

BAŞLANGIÇ

Paroksizmal, şiddetli karın ağrısı atakları

≥ 1 saat süren, orta hat/periumbilikal, engelleyici ataklar; ataklar arası tam sağlıklı dönem.

ADIM 1

Öykü + muayene + büyüme

Atak paterni ve stereotipisi, eşlik eden otonom semptomlar (≥ 2), tetikleyiciler, migren aile öyküsü; persentil ve boy hızı, karın ve nörolojik muayene.

KARAR 1

Alarm bulgusu var mı?

Kilo kaybı, büyüme duraklaması, safralı/ınatçı kusma, GİS kanama, gece uyandıran veya lokalize ağrı, ateş, organomegali.

EVET → Organik hastalığı dışla

HAYIR → Non-invaziv değerlendirme

HEDEFLİ TETKİK

Görüntüleme ± cerrahi/endoskopi

Batın USG, gerekirse üst GİS pasaj (malrotasyon/intermittan volvulus), amilaz/lipaz, üriner sistem; atipik/baş ağrısı baskınsa nörogörüntüleme.

BASAMAKLI TARAMA

Sınırlı ilk-basamak test

Tam kan, CRP/sedim, KCFT, çölyak serolojisi, tam idrar, gaita kalprotektin; tümü normalse organik olasılık düşüktür.

KARAR 2

Rome IV karşılandı mı?

≥ 2 stereotipik atak, son 6 ay, ≥ 2 otonom eşlikçi, ataklar arası tam iyilik; semptomlar başka bir durumla açıklanamıyor.

EVET → Pozitif tanı

HAYIR → Yeniden değerlendir

TANI

Abdominal migren

AYIRICI TANI

Alternatif tanı ara

Tetikleyici kaçınma + atak tedavisi
(dinlenme, hidrasyon, analjezi/antiemetik).
Sık/engelleyici ataklarda profilaksi başla, 8-
12 haftada yanıt değerlendir.

İntermittan obstrüksiyon, rekürren pankreatit,
üriner sistem, IBD, herediter anjioödem, FMF,
metabolik (porfiri, mitokondriyal); hedefli
inceleme.

Alarm bulgusu yoksa tetkik kademeli ve sınırlı tutulur; görüntüleme ve invaziv inceleme atipik, dirençli veya alarmlı olgulara ayrılır. Mümkünse bir atak, hem cerrahi karnı dışlamak hem de ataklar arası normalliği belgelemek için değerlendirilir.

Alarm bulgusuz tekrarlayan atak paterninde kademeli değerlendirme

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Kan	Tam kan sayımı, CRP/ESR, KCFT, amilaz/lipaz, çölyak serolojisi (anti-tTG IgA + total IgA), üre/kreatinin, glukoz, elektrolit	Anemi, inflamasyon, pankreatit, çölyak taraması; atak sırasında pankreatit ayrımı için amilaz/lipaz değerli
Basamak 2 · İdrar/Gaita	Tam idrar tetkiki ± idrar kültürü, gaita gizli kan, fekal kalprotektin	Üriner enfeksiyon/taş ve IBD ayrımı; kalprotektin yüksekse endoskopiye yönlendirir
Basamak 3 · Görüntüleme	Batın ultrasonografisi (tercihen atak sırasında ve dışında)	Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu, safra/pankreas patolojisi, kitle, invajinasyon değerlendirmesi
Basamak 4 · Seçili GİS	Üst GİS pasaj grafisi; endikasyonla üst GİS endoskopi	Malrotasyon/intermittan volvulus şüphesi veya dispeptik/alarm bulgusu; rutin değil
Seçili · Nörolojik	Beyin MR	Baş ağrısı baskın, focal nörolojik bulgu, atipik/ilerleyici seyir; rutin değil
Seçili · Metabolik/İmmün	İdrar porfobilinojen (akut porfiri), amonyak/laktat (mitokondriyal), C1-esteraz inhibitörü/C4 (herediter anjioödem), FMF (MEFV) genetiği	Ataklar atipikse veya ailesel/etnik risk varsa hedefli; standart panelde değil

Cerrahi karın uyarısı: Şiddetli, safralı kusma ve distansiyonla giden atakta **malrotasyon-intermittan volvulus** ve invajinasyon acilen dışlanmalıdır; bu senaryoda görüntüleme (USG/üst GİS pasaj) ve cerrahi değerlendirme profilaksiden önce gelir.

Aşağıdakilerden herhangi biri abdominal migren tanısını sorgulattır ve hedefli tetkik ile organik/cerrahi hastalık dışlamasını gerektirir.

- İstemsiz kilo kaybı

- Doğrusal büyümede duraklama / boy hızında yavaşlama

- Safralı veya inatçı kusma

- GİS kanama: hematemez, melen, hematokezya

- Umbilikustan uzak, lokalize veya persistan (ataklar arası devam eden) ağrı

- Gece uyandıran ağrı

- Ataklar arasında tam iyileşmenin olmaması

- Karın distansiyonu, kitle, organomegali

- Açıklanamayan ateş

- Fokal nörolojik bulgu / papilödem

- Artrit, perianal hastalık, gecikmiş puberte

- IBD, çölyak veya rekürren pankreatit aile öyküsü

06 Tedavi

Yönetim üç ayaklıdır: (1) eğitim ve güvence, (2) tetikleyici kaçınma, (3) atak tedavisi ve seçili olguda profilaksi. Profilaksi endikasyonu; atakların sık (genellikle ayda $\geq 1-2$), engelleyici ve yaşam kalitesini/okul devamını bozacak şiddette olmasıdır. Profilaktik ajanlar en az 8-12 hafta denenip yanıtı göre sürdürülür veya değiştirilir.

Atak (akut) tedavisi

BASAMAK / İLAÇ

DOZ

Non-farmakolojik (tüm ataklar)

—

İbuprofen (analjezi)

7,5-10 mg/kg/doz (maks 400-600 mg/doz)

Ondansetron (antiemetik)

0,15 mg/kg/doz (maks 8 mg/doz)

İntranazal sumatriptan (seçili adölesan)

10 mg (20-39 kg) veya 20 mg (≥ 40 kg) intranazal (maks 20

Profilaksi — sık/engelleyici ataklarda (tekli ajan, 8-12 hafta dene)

İLAÇ	DOZ
Pizotifen (5-HT2 antagonisti)	0,5 mg gece başla; titre 0,5 mg × 2-3 doz (maks ~1,5 mg/gün)
Siproheptadin (5-HT/histamin antagonisti)	0,25-0,5 mg/kg/gün, 2-3 doz (maks ~0,5 mg/kg/gün; 10 mg/gün)
Propranolol (beta-bloker)	0,5-1 mg/kg/gün başla, 2-3 doz; titre (maks ~2-4 mg/kg/gün)
Amitriptilin (nöromodülatör, alternatif)	0,25-0,5 mg/kg/gece başla; titre (maks ~25-50 mg/gece)
Flunarizin (kalsiyum kanal blokeri, alternatif)	5 mg/gün (<40 kg) veya 10 mg/gün, gece
Topiramamat (alternatif)	1-2 mg/kg/gün, 2 doz, yavaş titrasyon (maks ~100 mg/gün)

Yaklaşım: Profilaksiste ajan yaşa ve komorbiditeye göre seçilir: küçük çocukta siproheptadin, en güçlü pediatrik kanıt için pizotifen, aura/otonom baskın veya baş ağrısı örtüşen olguda propranolol. Tek ajanla 8-12 hafta yanıt yoksa mekanizmaya göre değiştir; kombinasyondan kaçın. Atak sıklığı azaldıysa 4-6 ay sonra kademeli azaltmayı planla.

Tetikleyici kaçınma tedavinin köşe taşıdır: düzenli öğün (açlıktan kaçınma), düzenli-yeterli uyku, stres yönetimi, kafein/amin içeren gıda (çikolata, olgun peynir, narenciye) ve MSG/nitrit kısıtı; ekranların ve titreşen ışığın azaltılması. Tetikleyici günlüğü bireysel örüntüyü ortaya koyar.

07 İzlem ve yönetim ilkeleri

AM epizodik ve genellikle kendini sınırlayan bir seyir gösterir; birçok çocukta ataklar yıllar içinde azalır, ancak önemli bir kısmında ileride tipik migren gelişir. Hedef: atak yükünü azaltmak, işlevselliği ve okul devamını korumak, gereksiz tekrarlayan tetkiki önlemek.

İzlem

- Pozitif tanıyı biyopsikososyal açıklama ve güvence ile pekiştir; tekrarlayan invaziv tetkikten kaçın
- Atak günlüğü: sıklık, süre, şiddet, tetikleyici, atak tedavisine yanıt
- Profilaksiyi 8-12 haftada değerlendir; yanıt varsa 4-6 ay sürdür, sonra kademeli azalt
- Büyüme eğrisini her vizitte izle; yeni alarm bulgusu veya paternde değişiklikte yeniden değerlendir
- Erişkin migren riski açısından aileyi bilgilendir; ataklar arası tam iyilik beklentisini teyit et

Dirençli / atipik olguda

- Tanıyı ve ataklar arası normalliği yeniden gözden geçir; alternatif tanıları (obstrüksiyon, pankreatit, FMF, porfiri) ele al
- Profilaktik ajanı mekanizmaya göre değiştir (ör. siproheptadin/pizotifen → propranolol → nöromodülatör)
- Komorbiditeleri yönet: anksiyete/depresyon, uyku bozukluğu, taşıt tutması, otonom disfonksiyon
- Davranışsal tedaviye yönlendir: BDT, gevşeme/biofeedback, tetikleyici yönetimi
- Okul devamsızlığı ve aile beklentilerini yönet; multidisipliner (nöroloji, psikoloji) destek

En tutarlı sonuç; etkili güvence, sistematik tetikleyici kaçınma ve endikasyonu doğru konmuş profilaksinin birlikte kullanıldığı biyopsikososyal bir planla elde edilir. Farmakoterapi tek başına değil, bu çerçevede içinde konumlandırılmalıdır.

Kaynaklar

1. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Functional Disorders: Children and Adolescents (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.
2. Angus-Leppan H, Saatci D, Sutcliffe A, Guilloff RJ. Abdominal migraine. BMJ. 2018;360:k179.
3. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-3): episodic syndromes that may be associated with migraine. Cephalalgia. 2018;38(1):1-211.
4. Symon DNK, Russell G. Double blind placebo controlled trial of pizotifen syrup in the treatment of abdominal migraine. Arch Dis Child. 1995;72(1):48-50.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir.